今日論文 • 第 02 篇 公開全文

針灸聯合常規護理治療多囊卵巢綜合徵合併月經稀發：先導隨機對照試驗

Effect of Acupuncture Plus Usual Care versus Usual Care Alone for Oligomenorrhea in Women with Polycystic Ovary Syndrome: A Pilot Randomized Controlled Trial

作者	Li J, Yang C, Zhang J, Yang L, Hang T, Wang X, An D, Kim PW, Jung SY, Jun P, Kwon O, Lee JM, Lee CH, Zhao J, Fang Y, Xu H, Lee JH
期刊	International Journal of Women's Health（2026年10月22日發表；卷 18，文章 638897）
識別碼	PMID 42936675 • DOI 10.2147/IJWH.S638897 • PMC13701121 • ClinicalTrials.gov NCT04509817
取用	公開全文（DovePress／PMC）

官方連結（點擊即可打開）

- DovePress 全文 https://www.dovepress.com/effect-of-acupuncture-plus-usual-care-versus-usual-care-alone-for-olig-peer-reviewed-fulltext-article-IJWH
- PMC 全文 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13701121/
- PubMed 摘要 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42936675/
- DOI https://doi.org/10.2147/IJWH.S638897

研究是什麼

國際多中心、平行兩臂先導隨機對照試驗，在中國及韓國共三間門診，評估手法針灸加上常規護理（生活指導），相對於單用常規護理，對多囊卵巢綜合徵（PCOS）合併月經稀發女性月經頻率的影響，並觀察安全性。

方法要點

- 篩選 99 人，入組並隨機 60 人（每組 30 人）；其後對照組 2 人因基線誤診被排除出全分析集（FAS）。針灸組 22 人（73.3%）、對照組 25 人（83.3%）完成試驗。
- 納入 20–40 歲、符合 Rotterdam 標準且月經周期大於 35 日或每年少於 8 次的女性。
- 針灸組於 16 周內接受約 40 次標準穴位手法針灸，並加生活指導；對照組只接受生活指導。主要結局為基線至第 16 周每月月經次數的平均改變；次要結局屬探索性。
- 因干預性質，針灸師及受試者未能致盲；結局評估者及統計人員保持盲態。

主要結果

- FAS（針灸 30 人、對照 28 人）：針灸組月經頻率較對照組多改善 0.20 次／月（95% CI 0.11 至 0.28；P=0.002）。
- 周期長度亦較對照組多縮短 19.69 日（95% CI −29.42 至 −9.97；P<0.001）。
- 無嚴重不良事件。針灸組有 3 例治療相關皮下出血，對照組有 2 例輕微頭痛，均自行緩解。

- 第 32 周（停針後）月經頻率組間差不再顯著（均差 0.14；95% CI −0.06 至 0.34；P=0.646）。作者強調屬先導試驗，結果應視為初步。
- 體重指數、激素及超聲波等其他次要結局，在第 16 或 32 周均無顯著組間差異。

中醫診所臨床啟示

- 月經稀發或 PCOS 門診患者，可將針灸作為生活調理的輔助討論，並說明療效可能隨停針而減退。
- 本試驗未設假針對照，且未能對患者及針灸師致盲，對照組優勢須審慎解讀。
- 不能取代必要的內分泌評估、促排卵或生殖專科處理；妊娠或急性婦科情況須轉介。

限制與解讀注意

- 樣本量按先導試驗設計，統計效能有限；整體脫落率 21.7%，部分與新冠隔離有關。
- 基線月經頻率及周期長度兩組並不完全均衡，主要結局已用共變量分析校正，但仍須謹慎解讀。
- 改善月經頻率並不等於已確認恢復排卵；未按 PCOS 表型分層。

聲明：這份 PDF 由新聞bot 根據已核實的摘要及（如屬公開取用）論文頁面撰寫中文摘要，方便診所快速閱讀，並非出版社官方譯本，亦不是論文全文。關鍵數據請以官方全文為準。本摘要供專業參考，不能代替個別患者的臨床判斷。